

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO 2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN FISIOTERAPEUTA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

INSTRUCCIONES:

1º) La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.

2º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas y firmar cabecera.

3º) El ejercicio consta de 20 preguntas, más 5 preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de preguntas del cuestionario, a tal objeto.

4º) Cada pregunta acertada se computará con 1 punto.

5º) Deberán señalar la respuesta que consideren correcta rellenando completamente el cuadro correspondiente a dicha respuesta correcta.

Ejemplo:

☒	☐	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante la estampación de un aspa sobre dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.

Ejemplo:

☒	☒	☐	☐
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

En el supuesto de que quiera dar de nuevo por válida una pregunta anulada deberá cruzar con un aspa la que quiera anular y la válida se rodeará con un ovoide.

Ejemplo:

☒	☒	☐	☐
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

6º) Por cada 3 preguntas en blanco o erróneas se restará una.

7º) La duración del ejercicio será de 90 minutos.

8º) Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.

9º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil durante el ejercicio será causa de expulsión.

10º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro del Tribunal le recogerá su ejercicio. El aspirante se podrá llevar el cuestionario y entregará la hoja de respuestas cuya copia amarilla se le devolverá al aspirante.

11º) La plantilla de respuestas correctas será publicada en la Web: www.dipujaen.es a la mayor brevedad posible.

SUPUESTO PRÁCTICO

Varón de 70 años que ingresa en nuestra Residencia con hemiplejía izquierda y afectación de la marcha, va en silla de ruedas y hace vida cama-sillón. No presenta movilidad en hemicuerpo izquierdo, lleva el brazo en cabestrillo. No se observa afectación cognitiva, de visión ni del lenguaje. Sí presenta importantes síntomas depresivos por verse incapacitado para llevar una vida normal. Sin embargo, muestra ganas de recuperarse.

En una primera valoración, el área de fisioterapia observa:

- **Movilidad: amplitud articular conservada en hemicuerpo derecho. En el hombro izquierdo tiene 130° de flexión y 110° de abducción pasivos, con dolor en todo su recorrido. Codo y muñeca sin limitación.**
- **Fuerza muscular: en el hemicuerpo derecho se testa una fuerza de 5 según la escala Daniel's. -2 en hombro y codo izquierdos, 0 en mano y dedos izquierdos.**
- **Hipotonía en el brazo izquierdo y en el tronco, con desequilibrio en sedestación.**
- **Necesita ayuda para todas las actividades de la vida diaria, salvo para comer, ya que es diestro. Controla esfínteres.**
- **No tiene deterioro cognitivo. Sabe leer y escribir correctamente.**
- **Se relaciona con otros residentes y con los trabajadores de manera cordial, es simpático y agradable, aunque le gusta estar solo.**

1. ¿Qué grado de dependencia tiene este paciente según la escala Barthel?

- a. Dependencia Total.
- b. Dependencia Grave.
- c. Dependencia Moderada.
- d. Dependencia Leve.

2. ¿Cuál es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de ictus isquémico?

- a. Edad.
- b. Diabetes mellitus.
- c. Hipertensión arterial diastólica.
- d. Dislipidemia.

- 3. A la hora de diagnosticar/identificar el ictus es imprescindible la exploración neurológica y para que sea completa y rápida es muy útil el empleo de escalas de valoración neurológica, siendo la más utilizada:**
- La escala NIH (NIHSS)
 - El índice de Barthel.
 - La escala de marcha y equilibrio de Tinetti.
 - Evaluación del Dispositivo Familiar (FAD).
- 4. A la hora de realizar la valoración y evaluación de resultados tenemos a nuestro alcance una serie de “Instrumentos Estándar para Evaluación de Pacientes con ACV”. Cuál de los siguientes no estaría incluido en ellos:**
- Escala Norton
 - NIH: escala de ictus.
 - Índice de Barthel.
 - Escala de Berg.
- 5. La Escala de Ashworth modificada incluye 5 ítems más un sub-ítems, que van:**
- De 0 a 4, incluyendo un ítem adicional en el ítem 1.
 - De 0 a 4, incluyendo un ítem adicional en el ítem 2.
 - De 0 a 4, incluyendo un ítem adicional en el ítem 3.
 - De 0 a 4, incluyendo un ítem adicional en el ítem 4.
- 6. ¿Para la realización de la Escala Berg que “equipamiento o material” es necesario?**
- Cronómetro o reloj con segundero, regla u otro indicador de 5, 12 y 25 cm.
 - Escalón o taburete (de altura similar a un escalón) y sillas.
 - Una mesa baja con un vaso lleno de agua.
 - Las respuestas a) y b) son correctas.
- 7. La escala NIHSS determina de forma numérica la gravedad de un ictus, ¿qué gravedad nos sugiere una puntuación de 24 en dicha escala?**
- Ictus leve.
 - Ictus grave.
 - Ictus moderado.
 - Ictus muy grave.

8. ¿Qué nos indicaría una puntuación de 39 en la escala de Berg?

- a. Sin riesgo para caminar.
- b. Alto riesgo de caída, precisa silla de ruedas.
- c. Moderado riesgo de caída, puede caminar con ayudas.
- d. Leve riesgo de caída, puede caminar independientemente.

9. Identifique de los siguientes los factores pronósticos en la evolución del ictus que no están relacionados con la gravedad clínica del ictus:

- a. Déficit motor.
- b. Control de tronco en sedestación.
- c. Etiología.
- d. Incontinencia urinaria.

10. Cuál es la postura típica que adquiere el pie en la etapa espástica:

- a. Flexión dorsal y supinación.
- b. Flexión plantar y supinación.
- c. Flexión dorsal y pronación.
- d. Flexión plantar y supinación.

11. ¿Qué indica un grado 2 en la escala de Daniels?

- a. El músculo realiza una contracción palpable aunque no se evidencie movimiento.
- b. El músculo realiza todo el movimiento de la articulación una vez se le libera del efecto de la gravedad.
- c. El músculo no completa todo el movimiento de la articulación una vez se le libera del efecto de la gravedad.
- d. El músculo no realiza el movimiento de la articulación una vez que se le libera del efecto de la gravedad.

12. Señala la falsa:

- a. En la fase flácida ocurre el desarrollo gradual de la espasticidad.
- b. La espasticidad suele desarrollarse en los músculos extensores de los miembros inferiores.
- c. La espasticidad suele disminuir con las actividades y con el esfuerzo al inicio de su desarrollo.
- d. A medida que se desarrolla la espasticidad existe una resistencia creciente a ciertos movimientos pasivos.

13. ¿Cuál es la medida preventiva más útil del hombro doloroso?

- a. Correcta alimentación.
- b. Colocación correcta del hombro.
- c. Las respuestas b) y d) son correctas.
- d. Educación del equipo multidisciplinar, del paciente y la familia en el manejo correcto del brazo pléjico.

14. ¿Cuándo está indicado el uso de la inyección de toxina botulínica en combinación con fisioterapia?

- a. Solo en pacientes con espasticidad focal grave.
- b. Para reducir el tono muscular.
- c. Para aumentar el balance articular.
- d. Todas son correctas.

15. Los factores que pueden contribuir a la aparición del hombro doloroso son:

- a. Heminegligencia.
- b. Espasticidad.
- c. Falta de sensibilidad.
- d. Todas las respuestas son correctas.

16. Según el Método Bobath, en el paciente hemipléjico los principales factores de actividad refleja postural anormal que interfieren en el movimiento son:

- a. Reacciones no asociadas.
- b. Efecto de la reacción de apoyo positiva liberada.
- c. Efecto de la actividad tonicocervical refleja simétrica liberada.
- d. Todas son correctas.

17. El Método Bobath se preocupa principalmente de la evaluación de:

- a. Rangos de movimiento.
- b. Fuerza muscular.
- c. Patrones de movimiento.
- d. Todas son correctas.

18. Según el concepto Bobath, en cuanto a las pruebas de localización de presión y tacto leve en un paciente hemipléjico, es falso que:

- a. La localización del tacto suele ser mejor en la pierna que en el brazo.
- b. La localización del tacto suele ser mejor en el brazo que en la pierna.
- c. La apreciación del tacto sobre los dedos suele estar ausente.
- d. Si la localización está alterada, el paciente suele referir el punto de tacto proximalmente.

19. Según el Método Bobath, ¿qué reacciones posturales se deben examinar en el paciente hemipléjico?:

- a. Reacciones de equilibrio arrodillado a cuatro patas.
- b. Reacciones de equilibrio de pie apoyado sobre la pierna sana, la pierna afectada elevada.
- c. Reacciones de equilibrio de pie, los pies de puntillas.
- d. Reacciones de equilibrio tumbado, decúbito supino a prono.

20. Según el concepto Bobath, el generador central de patrones se encuentra establecido en:

- a. La médula y el cerebelo.
- b. La médula y el tronco del encéfalo.
- c. El tronco del encéfalo y el bulbo.
- d. La médula y el cortex cerebral.

PREGUNTAS DE RESERVA

21. Señala la respuesta verdadera sobre el método Bobath:

- a. Es una técnica de rehabilitación neuromuscular.
- b. El fisioterapeuta guía los ejercicios a través de los puntos clave de control motor.
- c. Pretende abolir las sincinesias y esquemas motores anormales.
- d. Todas son correctas.

22. ¿Cuál de los métodos de propiocepción utiliza esquemas de movimiento facilitador de carácter espiral y diagonal?

- a. Método Bobath.
- b. Método Perfetti.
- c. Método Kabat.
- d. Método Klapp.

23. De las siguientes escalas, ¿cuál no pertenece al grupo de escalas de limitación de la movilidad?

- a. Índice de Barthel.
- b. Escala de Fugl-Meyer.
- c. Escala del equilibrio de Berg.
- d. Medida de independencia funcional (FIM).

24. La heminegligencia visuo-espacial (HVE) se manifiesta a nivel comportamental de múltiples formas, entre ellas podemos citar:

- a. Ignorar parte de los alimentos del plato.
- b. No encontrar los cubiertos situados en el lado contralesional.
- c. Afeitarse o maquillarse la mitad de la cara.
- d. Todas son correctas.

25. La reeducación del paciente con ictus es un proceso limitado en el tiempo y orientado por objetivos, dirigido a permitir que personas con discapacidad consigan:

- a. Un nivel económico, social y mental óptimos.
- b. Un nivel funcional, mental, físico y social óptimos.
- c. Un nivel funcional, mental y cultural óptimos.
- d. Un nivel educativo, físico y económico óptimos.

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL SEGUNDO EJERCICIO (PRÁCTICO) DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO 2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN FISIOTERAPEUTA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

PREGUNTA N°	RESPUESTA CORRECTA
1	B
2	C
3	A
4	A
5	A
6	D
7	B
8	C
9	C
10	ANULADA
11	C
12	C
13	C
14	D
15	D
16	B
17	C
18	B
19	A
20	B
21	D
22	C
23	B
24	D
25	B

NOTA: De conformidad con la Base Séptima de la Convocatoria, los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, partir del día siguiente a la publicación de esta Plantilla, a fin de que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas sobre el cuestionario (**Plazo: Del 15 al 23 de abril, ambos inclusive**).



Aquellos aspirantes que presenten alegaciones en el plazo indicado deberán hacerlo a través del Registro General de esta Diputación o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no obstante, a los efectos de agilizar el proceso se ruega que se adelanten los escritos mediante su envío a la siguiente dirección de correo electrónico: convocatoriaspublicas@dipujaen.es

Jaén a 12 de abril de 2019